BVĐK NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/ĐA-PĐD

Châu Đốc, ngày 10 tháng 01 năm 2020

ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNGNĂM 2020

I. CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/11/2011 quy định về hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Căn cứ vào kết quả cuộc kiểm tra Bệnh viện đa khoa Nhật Tân của Sở Y tế về chất lượng bệnh viện cuối năm 2019.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Bệnh viện.

Nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế. Phòng điều dưỡng bệnh viện đa khoa Nhật Tân xây dựng đề án cải tiến chất lượng như sau:

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA KHOA

1. Tình hình chung

Do sự phát triển không ngừng của xã hội, kéo theo nhu cầu cần được chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người bệnh và từ sự cạnh tranh về thu hút người bệnh qua các dịch vụ y tế của các bệnh viện công lập. Nên việc cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ về chăm sóc sức khỏe người bệnh của phòng điều dưỡng tại bệnh viện Nhật Tân ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

➢ Cơ sở vật chất:

- Phòng Điều dưỡng và các khoa đều có bố trí trang thiết bị đầy đủ, tạo thuận tiện nơi làm việc.

➢ Nhân sự: Hiện tại bệnh viện có 10 khoa Lâm sàng, 05 khoa Cận lâm sàng và Phòng điều dưỡng có 03 nhân sự: 03 CNĐD.

Số nhân sự hiện có:

+ Các khoa Lâm sàng: 131 nhân viên, bao gồm: Điều dưỡng là 112 (Cử nhân 13, cao đẳng 29, trung học 70), nữ hộ sinh 19 (Cử nhân 1, cao đẳng 4, trung học 14)

+ Các khoa Cận lâm sàng:

- Khoa Dược: 18 nhân viên, bao gồm: 1 DS.CKI, 2 đại học, 3 cao đẳng, 12 trung học.
- Khoa Xét nghiệm: 8 KTV, bao gồm: 1 DS.CKI, 5 cử nhân, 2 trung học.
- Khoa Dinh dưỡng: 2 nhân viên, bao gồm: 2 trung học.
- Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn: 3 nhân viên, bao gồm: 1 cử nhân, 2 trung học.
- Khoa Chẩn đoán Hình ảnh: 12 KTV, bao gồm: 1 cử nhân, 11 trung học.

Trang thiết bị: Bệnh viện có đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết cho việc chăm sóc người bệnh cũng như trong công tác đào tạo, tập huấn và thực hành tại cơ sở.

2. Mặt mạnh

- Được Ban Giám Đốc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phòng điều dưỡng hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Được hỗ trợ từ các phòng chức năng, bác sĩ trưởng khoa và bộ phận tạo kiều kiện tốt trong công tác chăm sóc người bệnh.

- Các điều dưỡng trưởng, nhân viên có nâng lực, năng nổ trong công việc được tạo điều kiện nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn.

- Được bệnh viện cung cấp đầy đủ vật tư và các quy trình kỹ thuật thường xuyên cập nhật mới.

3. Mặt hạn chế

Số điều dưỡng trưởng khoa có trình độ đại học còn ít (chiếm trên 50%), ảnh hưởng rất nhiều đến công tác điều hành và hoạt động chuyên môn. Trình độ giữa các điều dưỡng chưa đồng đều trong công tác.

4. Cơ hội

Hiện tại bệnh viện đã và đang xây dựng khang trang và sạch đẹp, từ 150 giường bệnh năm 2019 đang phấn đấu lên 250 giường vào năm 2020. Cơ chế BHYT thông tuyến, bệnh nhân ngày càng đông. Ban Giám Đốc ủng hộ công tác điều dưỡng. Điều dưỡng trưởng các khoa nhiệt tình và năng nổ. Bác sĩ trưởng các khoa, phòng ủng hộ tốt.

5. Thách thức

- Áp lực chuyên môn đi kèm với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày cao của người bệnh làm cho bệnh viện phải đổi mới và phát triển liên tục.

- Sự cạnh tranh thu hút người bệnh cũng như nguồn nhân lực của các Bệnh viện lân cận.

Tuy nhiên với phương châm của bệnh viện là không ngừng đổi mới, quyết tâm cải tiến chất lượng bệnh viện liên tục, không ngừng xây dựng một môi trường thân thiện, văn minh nhằm tạo thuận lợi nhất để từng cán bộ viên chức bệnh viện phát huy hết năng lực, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

6. Vấn đề ưu tiên cải tiến trong khoa

- Nâng cao kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp.

- Phát huy hết năng lực của từng nhân viên trong công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh.

- Hạn chế sai sót chuyên môn.

III. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Mục tiêu chung (mục tiêu dài hạn)

- Bổ nhiệm đầy đủ các điều dưỡng trưởng khoa là cử nhân và có chứng chỉ quản lý điều dưỡng.

- Tổ chức điều dưỡng chăm sóc toàn diện cho 100% bệnh nhân nội trú.

2. Mục tiêu cụ thể năm 2020

Phòng điều dưỡng xây dựng 10 chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh và công tác điều dưỡng:

- Tỷ lệ người bệnh loét do tỳ đè < 0.5‰.

- Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ < 0.5%.

- Tỷ lệ tuân thủ quy trình kỹ thuật của điều dưỡng theo bảng kiểm ≥ 90%.

- Tỷ lệ sự cố y khoa do dùng thuốc cho người bệnh < 0.5‰.

- Tỷ lệ điều dưỡng tham gia đào tạo liên tục 100%.

- Tỷ lệ điều dưỡng trên giường bệnh đạt 100%.

- Hộp thuốc chống sốc đầy đủ cơ số theo quy định 100%.

- Tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ quy trình giao tiếp buồng bệnh (thực hiện đúng 5 bước) đạt 50%.

- Bệnh nhân chăm sóc cấp I được điều dưỡng làm kế hoạch chăm sóc 100%.

- Xây dựng tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe theo mô hình bệnh tật tại khoa (Mỗi khoa xây dưng tối thiểu 10 quy trình).

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG, GIÁM SÁT MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA PHÒNG

1. Tỷ lệ người bệnh loét do tỳ đè trong khi nằm viện < 0.5‰

- Tăng cường công tác chăm sóc người bệnh đang nằm viện.

- Đánh giá người bệnh có nguy cơ, cung cấp chế độ ăn hợp lý.

- Tăng cường hướng dẫn, giáo dục sức khỏe từ lúc vào viện và khi ra viện.

- Cung cấp đầy đủ quần áo, dra giường sạch sẽ.

➢ Báo cáo bằng giấy theo mẫu.

➢ Các khoa lập số liệu báo cáo.

➢ Người chịu trách nhiệm và báo cáo hàng quý: CN. Mai Thị Hoa Hồng

➢ Kinh phí thực hiện: Không

Phương pháp đo lường:

$$\text{Tỷ lệ NK loét do tỳ đè} = \frac{\text{Số BN bị loét trong khi nằm viện}}{\text{Tổng số BN nằm viện}} \text{ X } 1000$$

➢ Kết quả đầu ra: Phát hiện sớm, chăm sóc kịp thời sẽ làm giảm các trường hợp mắc so với năm 2019.

2. Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ < 0.5%

- Tăng cường rửa tay thường quy trước khi thực hiện chăm sóc vết mổ.

- Đánh giá đầy đủ, chính xác tình trạng vết mổ.

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, chăm sóc vô khuẩn.

- Hướng dẫn người bệnh cách theo dõi, chăm sóc trong khi nằm viện và sau khi ra viện.

➢ Báo cáo bằng giấy theo mẫu.

➢ Các khoa lập số liệu báo cáo hàng tháng, người báo cáo: CN. Nguyễn Thị Diễm Phương.

➢ Người chịu trách nhiệm: CN. Võ Hồng Thái.

➢ Kinh phí thực hiện: Không.

Phương pháp đo lường:

$$\text{Tỷ lệ NK vết mổ} = \frac{\text{Số BN bị nhiễm khuẩn vết mổ}}{\text{Tổng số BN được phẫu thuật}} \text{ X } 100$$

➢ Kết quả đầu ra: Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ giảm xuống so với năm 2019.

3. Tỷ lệ tuân thủ quy trình kỹ thuật của điều dưỡng theo bảng kiểm ≥ 90%

- Cập nhật quy trình kỹ thuật, trình Hội đồng khoa học kỹ thuật phê duyệt, triển khai tập huấn điều dưỡng. Kết hợp với ĐDTK giám sát thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra đột xuất tại các khoa Lâm sàng ít nhất 50% điều dưỡng/quý.

- Tổ chức thi tay nghề cho tất cả điều dưỡng 1 lần/năm.

➢ Thực hiện theo bảng kiểm ban hành.

➢ Báo cáo mỗi năm.

➢ Người chịu trách nhiệm: CN. Võ Hồng Thái.

➢ Kinh phí thực hiện: 500.000 đồng.

Phương pháp đo lường:

$$\text{Tỷ lệ tuân thủ quy trình} = \frac{\text{Số ĐD không tuân thủ}}{\text{Tổng số ĐD tuân thủ quy trình}} \text{ X } 100$$

➢ Kết quả đầu ra: Tỷ lệ tuân thủ quy trình kỹ thuật khi chăm sóc của điều dưỡng tăng hơn 2% so với năm 2019.

4. Tỷ lệ sự cố y khoa do dùng thuốc cho người bệnh (số lần dùng thuốc) < 0.5‰

- Thực hiện đầy đủ, đúng y lệnh điều trị.

- Tuân thủ 3 kiểm tra, 5 đối chiếu, 5 đúng khi thực hiện y lệnh.

- Thực hiện công khai thuốc hàng ngày về số lượng, số lần cho người bệnh.

- Hướng dẫn, thực hiện hoặc giám sát khi người bệnh dùng thuốc.

➢ Các khoa báo cáo ngay khi có sự cố.

➢ Báo cáo mỗi quý, người tổng hợp báo cáo: ĐD. Lý Thành Khanh.

➢ Người chịu trách nhiệm: CN. Võ Hồng Thái.

➢ Kinh phí thực hiện: Không.

Phương pháp đo lường:

$$\text{Tỷ lệ sự cố y khoa do dùng thuốc} = \frac{\text{Số sự cố y khoa do dùng thuốc}}{\text{Tổng số lần dùng thuốc cho BN}} \text{ X } 1000$$

➢ Kết quả đầu ra: Tỷ lệ sự cố y khoa do dùng thuốc cho người bệnh giảm hơn so

với năm 2019.

5. Tỷ lệ điều dưỡng tham gia đào tạo liên tục 100%

- PĐD lập kế hoạch tập huấn hàng năm, trình BGĐ phê duyệt.

- Mời các chuyên gia về tập huấn (cấp giấy chứng nhận).

- Cử ĐD đi học các lớp tập huấn có cấp giấy chứng nhận.

➢ Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, báo cáo BGĐ.

➢ Người chịu trách nhiệm: CN. Võ Hồng Thái.

➢ Kinh phí thực hiện: 40.000.000 đồng.

➢ Kết quả đầu ra: ĐD được đảm bảo đào tạo liên tục đủ 24 giờ/năm theo quy định.

6. Tỷ lệ điều dưỡng trên giường bệnh đạt 100%

- Thực hiện theo thông Tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 06 năm 2007 về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế "căn cứ vào: số lượng giường bệnh kế hoạch và công suất sử dụng buồng bệnh trung bình của 3 năm gần nhất. Đảm bảo đủ số điều dưỡng/giường bệnh.

- Kết hợp P.TCHC theo dõi, đánh giá tình hình nhân sự điều dưỡng tại các khoa, nhằm bổ sung nhân lực kịp thời.

- Các khoa Lâm sàng đảm bảo đầy đủ nhân lực hàng ngày và phân công số ĐD/số giường/số buồng vào sổ giao ban khoa.

➢ Kiểm tra, giám sát qua sổ giao ban hàng ngày của khoa.

➢ Người chịu trách nhiệm: CN. Võ Hồng Thái

➢ Kinh phí thực hiện: Không.

Phương pháp đo lường:

$$\text{Biên chế ĐD} = 1.40 \times \frac{91.14}{100} \times 190 = 0.245/\text{giường bệnh}$$

Ghi chú:

- Định mức biên chế tuyến 1 (người/giường bệnh) cho cơ sở khám chữa bệnh đa khoa đạt tiêu chuẩn hạng III, IV là 1.40.
- Chỉ số 91.14 % là công suất sử dụng buồng bệnh trung bình của 3 năm gần nhất.
- Chỉ số 190 là số giường bệnh kế hoạch.

➢ Kết quả đầu ra: Đảm bảo đầy đủ số lượng ĐD/giường bệnh chăm sóc cho người bệnh đạt 100% (2.45 người/10 giường bệnh).

7. Hộp thuốc chống sốc đầy đủ cơ số theo quy định 100%

- Cung cấp đầy đủ phác đồ chống sốc, hộp đựng và cơ số thuốc, vật tư y tế cho các khoa, phòng có thực hiện thuốc hoặc thủ thuật có xâm lấn hay không xâm lấn.

- Kiểm tra thường xuyên hộp chống sốc, đảm bảo đầy đủ số lượng.

➢ Kiểm tra hàng tháng, người tổng hợp báo cáo: DS. Trần Hoài Nam

➢ Người chịu trách nhiệm: CN. Võ Hồng Thái.

➢ Kinh phí thực hiện: Không.

➢ Kết quả đầu ra: Đảm bảo đầu đủ cơ số thuốc và phác đồ chống sốc tại các nơi cần thiết.

8. Tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ quy trình giao tiếp buồng bệnh (thực hiện đúng 5 bước) đạt 50%.

- Viết quy trình giao tiếp buồng bệnh, tập huấn, triển khai thực hiện.

- Kết hợp Tổ CTXH, ĐDTK kiểm tra, giám sát thực hiện.

- Khảo sát ý kiến Khách hàng, phân tích đánh giá và báo cáo kết quả.

- Kết hợp Tổ CTXH đề nghị khen thưởng, phạt, kỷ luật theo từng mức độ đối với cá nhân và tập thể.

➢ Lập phiếu đánh giá, báo cáo từng quý, người báo cáo CN. Võ Hồng Thái.

➢ Người chịu trách nhiệm: CN. Võ Hồng Thái.

➢ Kinh phí thực hiện: 240.000 đồng.

Phương pháp đo lường:

$$\text{Tỷ lệ tuân thủ} = \frac{\text{Số phiếu không tuân thủ}}{\text{Tổng số phiếu đánh giá}} \text{ X } 100$$

➢ Kết quả đầu ra: Kỹ năng giao tiếp của ĐD được nâng lên, tạo môi trường thân thiện cho Khách hàng trong lĩnh vực giao tiếp.

9. Bệnh nhân chăm sóc cấp I được điều dưỡng làm kế hoạch chăm sóc 100%

- Tập huấn điều dưỡng làm kế hoạch, bình kế hoạch chăm sóc hàng tháng.

- Kết hợp P.KHTH triển khai mẫu KHCS về các khoa Lâm sàng.

- PĐD đến khoa hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện.

- Các khoa thực hiện khi có bệnh nhân chăm sóc cấp I, dán vào hồ sơ bệnh án.

➢ NV P.KHTH kiểm tra HSBA xuất viện.

➢ Người chịu trách nhiệm: CN. Võ Hồng Thái.

➢ Kinh phí thực hiện: Không.

Phương pháp đo lường:

$$\text{Tỷ lệ BN làm kế hoạch} = \frac{\text{Số BN không làm kế hoạch}}{\text{Tổng số BN chăm sóc cấp I}} \text{ X } 100$$

➢ Kết quả đầu ra: Tất cả người bệnh chăm sóc cấp I được điều dưỡng theo dõi, lập KHCS cụ thể.

10. Xây dựng tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe theo mô hình bệnh tật tại khoa (Mỗi khoa xây dựng tối thiểu 10 quy trình)

- Làm đầu mối phân công các khoa cập nhật các bài truyền thông theo mô hình bệnh tật và lập bảng theo dõi lộ trình cập nhật tài liệu.

- Xây dựng tài liệu cho tất cả các bệnh thường gặp tại khoa hoặc ít nhất 10 quy trình truyền thông.

- PĐD tập hợp, phân tích, đóng góp ý kiến bổ sung, trình Hội đồng KHKT phê duyệt, ban hành.

➢ Người chịu trách nhiệm: CN. Mai Thị Hoa Hồng.

➢ Kinh phí thực hiện: 500.000 đồng.

➢ Phương pháp đo lường: Số tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe theo mô hình bệnh tật tại mỗi khoa có ít nhất 10 quy trình.

➢ Kết quả đầu ra: Tất cả các khoa Lâm sàng đều có xây dựng tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe.

V. BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Stt	Nội dung công việc	Thành viên
1	Tỷ lệ người bệnh loét do tỳ đè < 0.5%	CN. Mai Thị Hoa Hồng
2	Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ 0.5%.	CN. Nguyễn Thị Diễm Phương
3	Tỷ lệ tuân thủ quy trình kỹ thuật của điều dưỡng theo bảng kiểm > 90%.	CN. Võ Hồng Thái
4	Tỷ lệ sự cố y khoa do dùng thuốc cho người bệnh < 0.5%.	ĐD. Lý Thành Khanh
5	Tỷ lệ điều dưỡng tham gia đào tạo liên tục 100%.	CN. Võ Hồng Thái
6	Tỷ lệ điều dưỡng trên giường bệnh đạt 100%.	CN. Võ Hồng Thái
7	Hộp thuốc chống sốc đầy đủ cơ số theo quy định 100%.	DS. Trần Hoài Nam
8	Tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ quy trình giao tiếp buồng bệnh (thực hiện đúng 5 bước) đạt 50%.	CN. Võ Hồng Thái
9	Bệnh nhân chăm sóc cấp I được điều dưỡng làm kế hoạch chăm sóc 100%.	NV P. KHTH
10	Xây dựng tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe theo mô hình bệnh tật tại khoa (Mỗi khoa xây dưng tối thiểu 10 quy trình)	CN. Mai Thị Hoa Hồng

VI. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG (Phụ lục I)

VII. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN (Phụ lục II)

HỘI ĐỒNG QLCL	**TP. ĐIỀU DƯỠNG**
DS. Châu Thiên Bình	**CN. Võ Hồng Thái**

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 1

DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

TT	Khoản chi - Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Dụng cụ thi tay nghề	Bộ	2	500.000	1.000.000	
2	Kinh phí tổ chức khóa đào tạo liên tục 24h có cấp giấy chứng nhận.	Lớp	1	40.000.000	40.000.000	
3	In phiếu đánh giá điều dưỡng tuân thủ quy trình giao tiếp buồng bệnh	Phiếu	120	2.000	240.000	
4	In sổ tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe cho khoa	Cuốn	10	50.000	500.000	
	Tổng cộng				**41.740.000**	

Phụ lục 2

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

MS công việc	Mô tả cụ thể công việc	T/g cần thiết	T/g bắt đầu	CV cần hoàn thành trước	Tiến độ thời gian thực hiện (ghi theo tháng trong năm)												Chú thích
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	**Tỷ lệ người bệnh loét do tỳ đè trong khi nằm viện**																
	Thống kê, báo cáo người bệnh loét do tỳ đè các khoa lâm sàng. Báo cáo chỉ số chất lượng theo quý.	**3M**	01/01/ 2020				x			x			x			x	M: month
2	**Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ**																
	Thống kê, báo cáo người bệnh nhiễm khuẩn vết mổ các khoa lâm sàng. Báo cáo chỉ số chất lượng theo quý.	**3M**	01/01/ 2020				x			x			x			x	
3	**Tỷ lệ tuân thủ quy trình kỹ thuật của điều dưỡng theo bảng kiểm**																
	Cập nhật quy trình kỹ thuật, trình Hội đồng khoa học kỹ thuật phê duyệt, triển khai tập huấn điều dưỡng theo bảng kiểm ban hành.	**Y**												x			
	Kiểm tra đột xuất tại các khoa lâm sàng.	**W**	01/01/ 2020		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	W: week
	Tổ chức thi tay nghề điều dưỡng.	**Y**	Tháng 8	Tháng 10								x					

4	**Tỷ lệ sự cố y khoa do dùng thuốc cho người bệnh (số lần dùng thuốc)**																
	Thực hiện công khai thuốc hàng ngày về số lượng, số lần cho người bệnh Hướng dẫn, thực hiện hoặc giám sát khi người bệnh dùng thuốc.	**D**	01/01/ 2020		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D: Day
	Thống kê, báo cáo	**3M**					x			x			x			x	Y: year
5	**Tỷ lệ điều dưỡng tham gia đào tạo liên tục 100%**																
	Lập kế hoạch tập huấn hàng năm, trình BGĐ phê duyệt Mời các chuyên gia về tập huấn (cấp giấy chứng nhận).	**Y**	01/01/ 2020											x			
	Cử ĐD đi học các lớp tập huấn có cấp giấy chứng nhận.		01/01/ 2020														
6	**Tỷ lệ điều dưỡng trên giường bệnh đạt 100%**																
	Theo dõi, đánh giá tình hình nhân sự điều dưỡng tại các khoa, nhằm bổ sung nhân lực kịp thời. Các khoa Lâm sàng đảm bảo đầy đủ nhân lực hàng ngày và phân công số ĐD/số giường/số buồng vào sổ giao ban khoa.	**M**	01/01/ 2020		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	**Hộp thuốc chống sốc đầy đủ cơ số theo quy định 100%.**																
	Cung cấp đầy đủ phác đồ chống sốc, hộp đựng và cơ số thuốc, vật tư y tế cho các khoa, phòng có thực hiện thuốc hoặc thủ thuật có xâm lấn hay không xâm lấn. Kiểm tra thường xuyên hộp chống sốc, đảm	**M**	01/01/ 2020		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

	bảo đầy đủ số lượng.																
8	**Tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ quy trình giao tiếp buồng bệnh**																
	Viết quy trình giao tiếp buồng bệnh, tập huấn, triển khai thực hiện.		01/01/ 2020		x												
	Kết hợp Tổ CTXH, ĐDTK kiểm tra, giám sát thực hiện.	**D**	01/01/ 2020		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Khảo sát ý kiến Khách hàng, phân tích đánh giá và báo cáo kết quả.	**3M**	01/01/ 2020				x			x			x			x	
	Kết hợp Tổ CTXH đề nghị khen thưởng, phạt, kỷ luật theo từng mức độ đối với cá nhân và tập thể.	**Y**	01/01/ 2020												X		
9	**Bệnh nhân chăm sóc cấp I được điều dưỡng làm kế hoạch chăm sóc 100%.**																
	Triển khai mẫu KHCS về các khoa Lâm sàng. PĐD đến khoa hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện Tập huấn điều dưỡng làm kế hoạch, bình kế hoạch chăm sóc hàng tháng.	**M**	01/01/ 2020		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	**Xây dựng tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe theo mô hình bệnh tật tại khoa (Mỗi khoa xây dưng tối thiểu 10 quy trình)**																
	Làm đầu mối phân công các khoa cập nhật các bài truyền thông theo mô hình bệnh tật và lập bảng theo dõi lộ trình cập nhật tài liệu. Xây dựng tài liệu cho tất cả các bệnh thường gặp tại khoa hoặc ít nhất 10 quy trình truyền thông. PĐD tập hợp, phân tích, đóng góp ý kiến bổ sung, trình Hội đồng KHKT phê duyệt, ban hành.	**Y**	01/01/ 2020	Tháng 11											x		

Phụ lục 3

BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHOA NĂM 2020

Stt	Mục tiêu	Thành viên theo dõi	Thành viên thực hiện	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được	
					Có	Không
1	Tỷ lệ người bệnh loét do tỳ đè	Tổ QLCL	PĐD	< 0.5‰		
2	Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ	Tổ QLCL	K.KSNK	0.5%.		
3	Tỷ lệ tuân thủ quy trình kỹ thuật của điều dưỡng theo bảng kiểm	Tổ QLCL	PĐD	≥ 90%.		
4	Tỷ lệ sự cố y khoa do dùng thuốc cho người bệnh	Tổ QLCL	K.Dược	< 0.5‰		
5	Tỷ lệ điều dưỡng tham gia đào tạo liên tục	P. TCHC	PĐD	100%.		
6	Tỷ lệ điều dưỡng trên giường bệnh	P. TCHC	PĐD	100%.		
7	Hộp thuốc chống sốc đầy đủ cơ số theo quy định	Tổ QLCL	K. Dược	100%.		
8	Tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ quy trình giao tiếp buồng bệnh (thực hiện đúng 5 bước)	Tổ QLCL	PĐD + T.CTXH	50%.		
9	Bệnh nhân chăm sóc cấp I được điều dưỡng làm kế hoạch chăm sóc	P.NVTH	PĐD	100%.		
10	Xây dựng tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe theo mô hình bệnh tật tại khoa.	Tổ QLCL	PĐD	Xây dựng tối thiểu 10 quy trình		